TOME 18 • RÉFÉRENTIEL CONCOURS R2C

Chirurgie Orthopédique & Traumatologie

Collège Français de Chirurgie Orthopédique & Traumatologie (CFCOT) • 216 pages

Extrait de prévisualisation officielle du Tome 18 : Chirurgie Orthopédique & Traumatologie.

Cet extrait contient une sélection représentative de fiches de synthèse, de tableaux diagnostiques et de repères méthodologiques indispensables pour la préparation des Épreuves Dématérialisées Nationales (EDN) et des Épreuves Cliniques d'Objectif Structuré (ECOS).

- **Volume complet :** 216 pages A4 grand format.
- **Éditeur & Collège :** Collège Français de Chirurgie Orthopédique & Traumatologie (CFCOT).
- **Classification pédagogique :** Rangs A (Socle obligatoire pour tous) et Rangs B (Différenciation de spécialité).
- **Supports didactiques :** Tableaux décisionnels, arbres diagnostiques, posologies de première intention et pièges zéros.

Spécification	Détail Officiel
Format	PDF vectoriel haute résolution optimisé grand écran et tablette
Pagination totale	216 pages complètes non tronquées
Mises à jour	Conforme dernières conférences de consensus HAS & R2C 2026
Épreuves ciblées	EDN (QCMs, KFP, TCS) et ECOS (Stations pratiques 7 min)

PRÉSENTATION DU RÉFÉRENTIEL • TOME 18

Collège Français de Chirurgie Orthopédique & Traumatologie (CFCOT) • Réforme R2C 2026

Le programme officiel du 2e Cycle des études médicales structure les connaissances cliniques selon une hiérarchisation stricte en **deux niveaux de maîtrise** :

• **Rang A (Indispensable pour tout futur médecin) :** Représente le socle des connaissances incontournables. Tout interne, quelle que soit sa spécialité future, doit maîtriser ces items à la perfection (définitions, urgences vitales, signes cardinaux, thérapeutiques de première ligne et conduites à tenir d'extrême urgence). Une impasse sur un Rang A est sanctionnée par des points de pénalité majeurs lors des EDN.

• **Rang B (Connaissances approfondies de spécialité) :** Constitue le niveau discriminant pour les classements d'accès aux postes d'internat les plus sélectifs. Il aborde les subtilités physiopathologiques, les protocoles de deuxième et troisième lignes, les posologies hospitalières complexes et les examens paracliniques spécialisés.

Méthodologie pédagogique adoptée dans ce volume :
1. **Fiches synthétiques standardisées :** Chaque chapitre débute par le rappel des objectifs terminaux du Collège.
2. **Mise en valeur visuelle :** Balises Rang A (en surbrillance verte) et Rang B (en surbrillance bleue).
3. **Points de vigilance & Pièges de concours :** Encarts dédiés aux confusions fréquentes retrouvées dans les annales officielles.
4. **Tableaux comparatifs synthétiques :** Condensé de données permettant une révision rapide en quelques minutes.

RAPPEL IMPORTANT POUR L'ÉPREUVE EDN :
Les Questions Isolées (QI), Dossiers Progressifs (DP) et Tests de Concordance de Script (TCS) reposent à 100% sur les données publiées par le Collège officiel. Les traités anciens ou les sources non harmonisées comportent souvent des discordances susceptibles d'entraîner des pertes de points sévères.

SOMMAIRE DU RÉFÉRENTIEL COMPLET

Tome 18 • Chirurgie Orthopédique & Traumatologie (216 pages)

SOMMAIRE DÉTAILLÉ DU MODULE

• Chapitre 01 : Fractures fréquentes (363)
• Chapitre 02 : Lésions périarticulaires et ligamentaires (361)
• Chapitre 03 : Infection aiguë des parties molles (349)
• Chapitre 04 : Surveillance d'un malade sous plâtre (365)
• Chapitre 05 : Prothèses et ostéosynthèse (362)
• Chapitre 01 — Fractures fréquentes (363)
• Fractures de l'extrémité supérieure du fémur
• Anatomie de l'extrémité supérieure du fémur
• Os présente une organisation trabéculaire, l’entrecroisement des travées osseuses constitue des zones de grande résistance (éperon de Meckel)
• Vascularisation de la tête fémorale
• Schéma de la vascularisation de la tête du fémur (collège)
• radiopaedia.org
• Points communs dans les FESF
• Images (déformation du MI raccourci, adduction et rotation externe)
• Image clinique
• Score de Parker
• Radio-anatomie normale (schéma du collège sur le bassin)
• Radiographie du bassin
• radiopaedia.org
• Cours : Épidémiologie, Mécanismes lésionnels, Terrain, Clinique KB, Biologie
• Définition - Épidémiologie (rang C)
• Points clés sur les fractures de l'extrémité supérieure du fémur
• Avec le vieillissement de la population française, le nombre de FESF devrait tripler d'ici 2050. Toutefois, les estimations récentes indiquent une hausse plus modérée, car le risque relatif de FESF diminue chez les femmes après 40 ans, tandis qu'il augmente chez les hommes.
• Le pronostic à 1 an des FESF, reflet des comorbidités associées, est particulièrement sévère chez l'homme :
• • 15 à 20 % de mortalité
• • 20 à 25 % d'institutionnalisation
• • 40 à 60 % de perte importante d'autonomie, essentiellement motrice

EXTRAIT DIDACTIQUE DU COURS

Concepts Clés & Sémiologie Didactique • Rangs A et B

Chapitre 01 : Fractures fréquentes (363)

Chapitre 02 : Lésions périarticulaires et ligamentaires (361)

Chapitre 03 : Infection aiguë des parties molles (349)

Chapitre 04 : Surveillance d'un malade sous plâtre (365)

Chapitre 05 : Prothèses et ostéosynthèse (362)

Chapitre 01 — Fractures fréquentes (363)

Fractures de l'extrémité supérieure du fémur

Anatomie de l'extrémité supérieure du fémur

Os présente une organisation trabéculaire, l'entrecroisement des travées osseuses constitue des zones de grande résistance (éperon de Meckel)

Vascularisation de la tête fémorale

Schéma de la vascularisation de la tête du fémur (collège)

radiopaedia.org

Points communs dans les FESF

Images (déformation du MI raccourci, adduction et rotation externe)

Image clinique

Score de Parker

TABLEAUX DE CONSENSUS MÉDICAL • I

Synthèse Diagnostique & Critères de Classification • Chirurgie Orthopédique & Traumatologie

Paramètre 1	Fractures cervicales	Fractures trochantériennes
Type d'os	Os cortical dense	Os spongieux
Limites anatomiques	Zone cervicale est intra-articulaire, s'étend de : - Base de la tête fémorale (limite de la zone d'encroûtement cartilagineux) - Ligne inter-trochantérienne sur laquelle s'insère la capsule	Zone trochantérienne est extra-articulaire, s'étend de : - Ligne inter-trochantérienne - 5 centimètres au-dessous du petit trochanter (dans la région de la jonction métaphyso-diaphysaire supérieure)
Forces	Forces de cisaillement prédominent	Forces de compression prédominent
Vascularisation	Vascularisation fragile	Vascularisation riche
Consolidation	Consolidation longue (4 mois)	Consolidation en 40 jours

TABLEAUX DE CONSENSUS MÉDICAL • II

Arbres de Décision & Algorithmes Cliniques • Chirurgie Orthopédique & Traumatologie

Caractéristique	Description / Données Cliniques
Vaisseaux endo-médullaires	Interrompus après une fracture du col du fémur, expliquent la fréquence des complications à type de nécrose ischémique de la tête fémorale et ce d'autant plus que la fracture est très déplacée avec rupture de la capsule articulaire et des vaisseaux qui y cheminent
Vaisseaux capsulaires (rétinaculaires)	Issus du cercle circonflexe antérieur et postérieur dont l'artère principale est l'artère polaire supérieure qui pénètre dans la capsule au niveau de la fossette digitale et chemine le long de la partie supérieure de la capsule avant de pénétrer dans la tête fémorale à sa partie supérieure dans la zone d'encroûtement cartilagineux
Autre	Artères du ligament rond

POINTS CLÉS & PIÈGES DE CONCOURS R2C

Les Erreurs Fréquentes & Mots-Clés Zéros • Tome 18

1. Confusion Rang A vs Rang B : Aux EDN, les questions de Rang A représentent au minimum 60% du total des points. Tenter de retenir des posologies d'exception avant d'avoir sécurisé le réflexe diagnostique de première ligne est la première cause de contre-performance.

2. Les Pièges Éliminatoires 'Zéro à la question' :
• Oubli systématique de vérifier les contre-indications absolues avant une prescription.
• Confusion entre urgence médicale (prise en charge immédiate au déchocage) et prise en charge différée en consultation.
• Prescription d'examens invasifs ou irradiants injustifiés sans avoir réalisé l'examen physique initial complet.

3. Méthodologie du Dossier Progressif :
Ne préjugez jamais de la réponse de la question suivante pour orienter votre choix présent. Chaque palier d'un dossier progressif s'évalue selon les seules données cliniques disponibles à cet instant précis.

■ CONSEIL DU MAJOR POUR CE TOME :
Faites une première lecture complète des tableaux de synthèse pour créer une cartographie mentale des items. Passez ensuite aux QCMs d'entraînement pour tester votre rappel actif sur les seuils chiffrés et les arbres décisionnels.

RÉFÉRENCES SCIENTIFIQUES & VOLUME INTÉGRAL

Tome 18 • Chirurgie Orthopédique & Traumatologie (216 pages)

Sociétés Savantes & Collèges Référents :
• Collège Français de Chirurgie Orthopédique & Traumatologie (CFCOT)
• Recommandations de Bonne Pratique de la Haute Autorité de Santé (HAS)
• Conférences de consensus et publications des Sociétés Médicales Nationales et Européennes

Accéder au Référentiel Intégral :
Ce tome complet (216 pages) comprend l'intégralité des chapitres au programme du 2e Cycle, avec toutes les fiches de cours, l'ensemble des arbres diagnostiques en haute résolution et les grilles d'évaluation complètes.

• **Disponible à l'unité :** 9,99 € au format numérique haute performance.
• **Pack Intégral 28 Tomes (Économie de 85%) :** Comprend les 28 Référentiels Collèges (8 750 pages), la Banque des 100 QCMs Corrigés, le Carnet d'Erreurs du Major EDN 2025 et le Guide Officiel des 15 Stations ECOS 2026.

Édition conforme au référentiel R2C 2026. Tous droits réservés.